06 Roteiro de entrevista: suplementos, substâncias e imagem corporal

Perguntas para a consulta do adolescente que treina. O uso dessas substâncias costuma ser clinicamente oculto, sem alterações confiáveis no exame físico[1]; por isso, perguntar faz parte do exame[2].

COMO CONDUZIR

- Comece com o adolescente e a família; depois, converse com ele a sós e explique o sigilo e os seus limites, previstos no art. 74 do Código de Ética Médica[3,4].
- Pergunte sem julgamento e anote produto e dose como se fossem medicamentos em uso.
- Use as respostas para montar o plano junto com o adolescente e marque o retorno antes de encerrar.

Esporte e objetivo

- Que esporte você pratica, quantas vezes por semana e por quanto tempo?
- Qual é o seu objetivo agora: desempenho, saúde ou aparência?
- Quem orienta o seu treino e a sua alimentação?

Comida

- Quantas refeições você faz por dia? O que come depois do treino?
- Evita algum grupo de alimentos? É vegetariano?
- Pula refeições ou restringe a comida para controlar o peso?

Suplementos

- **O que você tem tomado para treinar ou para mudar o corpo?**
- Qual produto, que dose, quantas vezes e há quanto tempo?
- Onde comprou, quem indicou e quanto gasta por mês?
- Você trouxe o rótulo ou pode me mostrar uma foto dele?

Outras substâncias

- Usa energético, pré-treino ou café antes de treinar?
- Alguém já ofereceu hormônio, injeção ou remédio para ganhar músculo ou perder peso?
- Usa laxante, diurético ou remédio para emagrecer?

Corpo e redes sociais

- Como você se sente com o seu corpo? Quanto tempo do dia passa pensando nele?
- Deixa de fazer coisas, como sair ou tirar a camisa, por causa do corpo?
- Fica muito mal quando perde um treino ou sai da dieta?
- Que perfis de treino e de corpo você segue nas redes?
- Já sofreu provocação por causa do corpo?

Uso de redes sociais, história de trauma, insatisfação corporal e sofrimento com a aparência são os temas sugeridos para o rastreio de dismorfia muscular[5].

Sono e treino de força

- Quantas horas você dorme nas noites de aula? (8 a 10 horas de 13 a 18 anos; 9 a 12 horas de 6 a 12 anos[6])
- Como é a sua semana de musculação: quantos dias, quanto tempo e com que descanso? A Organização Mundial da Saúde recomenda fortalecimento muscular e ósseo em pelo menos 3 dias por semana[7]; o alerta está na rotina que atrapalha a vida diária[5].

SINAIS QUE PEDEM UMA CONVERSA MAIS LONGA

Contados pela família: mudança rápida do corpo, comportamento agressivo ou oscilações de humor atípicas, aumento de pelos ou acne intensa, tempo excessivo na musculação e mudança de voz, especialmente em meninas[1].

No exame: o uso de esteroides anabolizantes causa com frequência ginecomastia e acne; nos meninos, atrofia testicular; nas meninas, hirsutismo e voz mais grave, que pode ser irreversível[8]. No rastreio de dismorfia muscular, um escore de 40 ou mais no MDDI (Muscle Dysmorphic Disorder Inventory) indica sintomas clinicamente significativos[5].

06 Modelo de registro no prontuário

Texto para copiar ou adaptar. Os campos entre colchetes são preenchidos na consulta; os parênteses lembram os valores de referência do kit.

AVALIAÇÃO DE SUPLEMENTOS E SUBSTÂNCIAS · ADOLESCENTE QUE PRATICA ESPORTE

ESPORTE [modalidade], [n] vezes por semana, [h] horas por sessão. Objetivo referido: [desempenho / saúde / aparência]. Orientação do treino: [quem].

ALIMENTAÇÃO [n] refeições por dia. Lanche pós-treino: [descrição]. Restrições: [nenhuma / vegetariano / outras]. Proteína estimada: [x] g/kg/dia (adolescente atleta: cerca de 1,5 g/kg/dia).

SUPLEMENTOS [produto, dose, frequência, tempo de uso, local de compra, quem indicou]. Rótulo com advertências obrigatórias e número de notificação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): [sim / não / não visto].

OUTRAS SUBSTÂNCIAS energético, pré-treino, cafeína, hormônios, injetáveis, diuréticos, laxantes: [negou / referiu: ...].

IMAGEM CORPORAL [sem preocupação relevante / insatisfação / sinais de dismorfia muscular]. MDDI: [escore, se aplicado].

SONO [h] horas nas noites de aula (meta: 8 a 10 horas de 13 a 18 anos; 9 a 12 horas de 6 a 12 anos).

EXAME peso [kg], estatura [cm], curva de crescimento [descrição], estadiamento puberal [estágio]. Acne, ginecomastia, outros achados: [descrição].

CONVERSA A SÓS [realizada], com explicação do sigilo e de seus limites (Código de Ética Médica, art. 74).

ORIENTAÇÃO comida primeiro; lanche pós-treino com cerca de [0,3 × peso] g de proteína; água durante o treino; sono. [Combinada a suspensão da creatina, não autorizada em suplementos antes dos 19 anos.] Material entregue: [itens do kit].

ENCAMINHAMENTOS [nutrição / saúde mental / endocrinologia / nenhum].

RETORNO [data], com a família.

FRASES QUE AJUDAM

- “Vou anotar o que você toma do mesmo jeito que anoto um remédio.”
- “Meu trabalho é você chegar bem ao fim do campeonato e da adolescência.”
- “Vamos testar por quatro semanas um lanche de comida e ver como você se sente no treino.”

QUANDO ENCAMINHAR

- Restrição alimentar, perda de peso ou alteração menstrual: avaliação para baixa disponibilidade energética (item 10).
- Sofrimento com a aparência, rotina rígida de treino e dieta ou escore elevado no MDDI: saúde mental.
- Suspeita de esteroides ou de produtos sem procedência: avaliação clínica e laboratorial dirigida.

FONTES

1. LaBotz M, Griesemer BA; Council on Sports Medicine and Fitness. Use of performance-enhancing substances. Pediatrics. 2016;138(1):e20161300. doi:10.1542/peds.2016-1300
2. Eisenberg ME, Wall M, Neumark-Sztainer D. Muscle-enhancing behaviors among adolescent girls and boys. Pediatrics. 2012;130(6):1019-26. doi:10.1542/peds.2012-0095
3. Society for Adolescent Health and Medicine. Confidential healthcare for adolescent minors and young adults: a position paper of the Society for Adolescent Health and Medicine. J Adolesc Health. 2025;77(4):791-6. doi:10.1016/j.jadohealth.2025.06.006
4. Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica: Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019. Brasília: CFM; 2019. Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf
5. Nagata JM, Hur JO, Murakami K, Ganson KT, He J, Murray SB, et al. Muscle dysmorphia in adolescents and young adults. Lancet Child Adolesc Health. 2026;10(2):122-34. doi:10.1016/S2352-4642(25)00283-4
6. Paruthi S, Brooks LJ, D'Ambrosio C, Hall WA, Kotagal S, Lloyd RM, et al. Recommended amount of sleep for pediatric populations: a consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med. 2016;12(6):785-6. doi:10.5664/jcsm.5866
7. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med. 2020;54(24):1451-62. doi:10.1136/bjsports-2020-102955
8. Nieschlag E, Vorona E. Mechanisms in endocrinology: medical consequences of doping with anabolic androgenic steroids: effects on reproductive functions. Eur J Endocrinol. 2015;173(2):R47-58. doi:10.1530/EJE-15-0080